

골반장기탈출증(POP)

WARWIKI

한자 안내문 · 골반 장기가 내려와 돌출(불룩함)이나 압박감을 유발하는 상태

골반장기탈출증(POP)은 방광, 자궁, 직장 등 골반 장기를 지지하는 조직이 약해져 하나 이상의 장기가 질 안쪽으로 또는 질 밖으로 내려오는 상태입니다. 이로 인해 돌출(불룩함)이나 압박감이 생깁니다. 매우 흔한 질환으로 위험하거나 암이 아니며, 운동부터 보조 기구, 수술까지 다양한 치료 선택지가 있습니다.

이 질환에 대하여

탈출증은 내려온 벽에 따라 이름이 붙습니다:

- **앞벽**(방광) — 방광류(cystocele)
- **뒷벽**(직장) — 직장류(rectocele)
- **상부**(자궁, 또는 자궁절제술 후 질 상단)

흔한 증상:

- 질 입구에서 보이거나 느껴지는 **돌출(불룩함)**
- 골반 **압박감이나 무거운 느낌**; 하루 끝 무렵이나 무거운 것을 들 때 악화
- 방광이나 장을 완전히 비우기 어려움; 배변·배뇨 시 불룩한 부위를 손으로 눌러야 하는 경우("스플린팅")

원인

골반 지지 조직을 약화시키는 요인: **임신과 출산**, 폐경과 노화, 만성 변비나 기침으로 인한 지속적인 힘주기, 무거운 물건 들기, 이전 골반 수술, 과체중, 가족력.

용어 설명

탈출증

골반 장기가 정상 위치에서 내려온 상태.

방광류

방광이 질 앞벽 쪽으로 불룩하게 내려온 것.

직장류

직장이 질 뒷벽 쪽으로 불룩하게 내려온 것.

질 상단(vault)

자궁절제술 후 내려올 수 있는 질의 상단 부위.

페서리

장기를 지지하기 위해 질 안에 삽입하는 제거 가능한 보조 기구.

스플린팅

배뇨·배변을 돕기 위해 불룩한 부위를 손으로 누르는 행위.

골반저

골반 장기를 지지하는 근육.

POP-Q

탈출 정도를 측정하는 진찰 방법.

반드시 치료해야 하나요? 증상이 없으면 치료하지 않아도 됩니다. 탈출증은 위험하지 않으므로 증상이 가벼우면 경과만 관찰할 수 있습니다. 불편함이나 일상생활에 지장이 생기면 여러 가지 효과적인 치료 중 선택할 수 있습니다 — 정답은 하나가 아니며, 시간이 지나면서 결정을 바꿀 수도 있습니다.

진단 방법

- 서 있거나 힘을 줄 때 시행하는 **골반 검진**으로 어느 벽이 얼마나 내려왔는지 확인
- 방광 및 장 관련 증상 검토
- 요실금이 동반된 경우 **방광 기능 검사** 시행

치료 방법 (단계별)

- 1 증상이 없으면 **경과 관찰**; 변비 치료, 무거운 것 들기 제한, 체중 조절로 예방.
- 2 가벼운 탈출증에는 **골반저근 운동 / 물리치료**.
- 3 **페서리** — 수술 없이 돌출을 완화하는 제거 가능한 보조 기구.
- 4 **수술** — 지지 구조 복원, 질 폐쇄술(colpocleisis), 또는 현수술. 각각 별도 안내문이 있습니다.

생활 관리

- 변을 부드럽게 유지하고 **힘주기를 피하세요**; 의뢰진이 권고한 이상의 무게는 들지 마세요.
- 골반저근 운동을 하고, 기침과 체중을 관리하세요.
- 페서리는 일시적 방법이 아닌 장기적 해결책이 될 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 소변을 보지 못하거나 배변이 되지 않는 경우
- 돌출 부위가 **통증, 출혈, 또는 짓무름/궤양**이 생긴 경우
- 발열이 있거나 돌출 부위를 안으로 밀어 넣을 수 없는 경우

기억할 세 가지

1. 골반장기탈출증은 골반 장기가 내려와 돌출(볼록함)이나 압박감을 일으키는 흔하고 위험하지 않은 상태입니다.
2. 불편할 때만 치료하면 됩니다 — 경과 관찰·운동·페서리·수술 중에서 선택할 수 있습니다.
3. 힘주기와 무거운 것 들기를 피하세요. 방광이나 장을 비우지 못하거나 돌출 부위가 아프거나 짓무르면 진료를 받으세요.